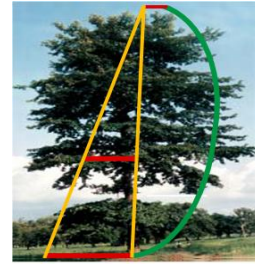




WAMFE

*sensibilisation sur
les
risques causés par le
mercure*



AED

***RAPPORT RELATIF A LA CONFERENCE DE PRESSE
CONTRE L'UTILISATION DE L'AMALGAME DENTAIRE
EN REPUBLIQUE DU CONGO***



(Les participants à la conférence de presse)

Brazzaville, 25 mai 2022

TABLE DES MATIERES

N°	Rubriques	Pages
	Sigles et abréviations	3
	Introduction	4
I	Présentation de la Convention de Minamata sur le mercure, ses exigences et ses activités de mise en œuvre en République du Congo	4
II	Notions de base sur le mercure, effets néfastes du mercure et de l'amalgame dentaire sur la santé et l'environnement	6
III	Film Japon Retour sur la catastrophe écologique de Minamata	7
IV	Etat de lieu de la dentisterie au Congo. Les alternatives actuelles	7
V	L'amalgame dentaire dans l'évaluation initiale du mercure en République du Congo. Amendement africain sur l'amalgame dentaire à la COP4 de la Convention de Minamata. Résultats de la COP4 de la Convention de Minamata sur le mercure	8
VI	S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes au Congo	11
VII	Suggestions	13
	Conclusion	15
VIII	Annexes	16
	- Allocution d'ouverture du Président de l'AED	17
	- Liste des participants	18

SIGLES ET ABREVIATIONS

AED :	Action sur l'Environnement et le Développement
ACC	Association des Consommateurs Congolais
A.C.D.D.C	Association Congolaise pour la Défense des Droits du Consommateur
ALGEC	Action Libérale pour la Gestion Environnementale au Congo
BOC	Bureau Ozone Congo
CCSC	Conseil Consultatif de la Société Civile
CSEE	Chef de Service de l'Evaluation Environnementale
CIO	Centre Interdiocésain des œuvres
COP4	Quatrième Conférence des Parties de la Convention de Minamata sur le mercure
DGE	Direction Générale de l'Environnement
EDIC	Environnement Développement des Initiatives Communautaires
EPA	Etablissement Public Administratif
FEM	Fonds Mondial pour l'Environnement
Hg :	Mercure
IRF :	Institut National de la Recherche Forestière
MIA :	Evaluation Initiale du Mercure (dans le cadre de la Convention de Minamata)
MSP	Ministère de la Santé et de la Population
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
ONU-Environnement :	Organisation des Nations Unies pour l'Environnement
PAN :	Plan d'action national pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or en Afrique (Projet PAN)
PFCM	Point Focal de la Convention de Minamata
PNUE :	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PPG Congo	Projet GOLD+ Congo
WAMFE :	Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans Mercure

INTRODUCTION

Le 25 mai 2022, s'est tenue dans la salle de Conférence du Centre Interdiocésain des œuvres (CIO), à Brazzaville, la conférence de presse contre l'utilisation de l'amalgame dentaire en République du Congo, organisée par l'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED) avec l'appui de l'Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans Mercure (AMDSM).

Un dossier comprenant l'invitation à la conférence de presse, la note conceptuelle de la conférence de presse, la plaquette d'informations générales sur le mercure et sur l'amalgame dentaire (plombage gris), l'agenda des travaux de la conférence de presse, a été distribué à tous les participants.

Monsieur **NIANGOU Maurice**, membre de l'AED et Modérateur de circonstance, a présenté l'objet de la conférence de presse contre l'utilisation de l'amalgame dentaire en République du Congo, tout en indiquant que la conférence de presse se tenait après la COP4 de la Convention de Minamata sur le mercure qui venait de se tenir du 21 au 25 mars 2022 à Bali, en Indonésie. .

Dans son allocution d'ouverture, le Président de l'AED, **Dr Eugène LOUBAKI**, a souhaité la bienvenue à tous les participants et a présenté l'amalgame dentaire, faussement appelé "plombage gris", comme un mélange de mercure avec d'autres métaux tels que l'argent, l'étain et le cuivre. Cet amalgame est largement utilisé dans notre pays pour la réparation des dents abîmées, mais la sécurité biologique de l'amalgame dentaire est aujourd'hui contestée.

Ensuite, les participants se sont, tour à tour, présentés et ont mis en place le présidium pour la conduite de la conférence de presse, composé ainsi qu'il suit :

Président : **LOUBAKI Eugène** Président de l'AED ;
Vice Président : **NKOUNKOU Guymel**, Représentant d'ALGEC;
Secrétaire : **MOUDZINGOULA Joseph** Secrétaire Général de l'AED ;
BAZOMA DONGUI Geneviève, Point Focal de la Convention de Minamata sur le mercure.

Par la suite, les participants ont suivi les cinq (5) exposés ci-après :

I. Présentation de la Convention de Minamata sur le mercure, ses exigences et ses activités de mise en œuvre en République du Congo, par Mme BAZOMA DONGUI Geneviève, Point Focal de la Convention de Minamata sur le mercure.

Au cours de cet exposé, Madame le Point focal s'est appesantie sur les points essentiels ci-après :

1.1. Bref Historique et motivations de la mise en place de la Convention de Minamata sur le mercure

Au Japon, de 1932 à 1966, une usine pétrochimique de la compagnie Shin Nippon Chisso rejeta des métaux lourds, en particulier du mercure, dans la baie de Minamata. Le mercure, ingéré par les poissons de la baie, s'est retrouvé dans les assiettes des habitants. Ceux-ci ont été sévèrement touchés par ce qui a ensuite été appelé "la maladie de Minamata" qui se traduit par des symptômes neurologiques, sensoriels et moteurs. La catastrophe de minamata a été

officiellement reconnue en 1956 et le Conseil d'Administration du PNUE, à sa 25^e session en 2009, avec plusieurs Ministres de l'environnement des différents pays, avait décidé de créer un accord juridiquement contraignant, sous la dénomination de « **Convention de Minamata sur le mercure** », adoptée le 19 Janvier 2013 à Kumamoto au Japon. A ce jour, 144 pays l'ont signé et 123 l'ont ratifié. Notre pays, le Congo, après la signature en octobre 2014, l'a ratifié le 06 août 2019.

1.2. L'objectif et les principales dispositions de la Convention de Minamata sur le mercure

L'objectif de la Convention de Minamata sur le mercure est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

La Convention de Minamata sur le mercure prévoit des dispositions visant à :

- Interdire de nouvelles activités d'extraction de mercure ;
- Eliminer progressivement l'utilisation du mercure dans des produits et dans des procédés de fabrication ;
- Elaborer un plan national d'actions ;
- Préconiser des meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales ;
- Gérer de façon écologiquement rationnelle les déchets de mercure et réhabiliter les sites contaminés par cette substance et ses composés ;
- Sensibiliser les populations aux effets néfastes du mercure sur la santé humaine et l'environnement ; et
- Fournir un appui technique et financier aux pays en développement pour réaliser la mise en œuvre de la Convention.

1.3. La mise en œuvre de la Convention de Minamata au niveau national

En 1ère phase, le Congo a bénéficié du financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) pour la réalisation des activités habilitantes. Deux projets ont été mis en œuvre de 2017 à 2018 :

- Evaluation initiale de la Convention de Minamata sur le mercure (MIA III), et ;
- Elaboration du Plan d'action national pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or (PAN).

En 2^{ème} phase, dans la suite du projet PAN, le Conseil du FEM a approuvé en juin 2020 le concept d'expansion de Planet GOLD, intitulé GOLD+, en ajoutant huit pays dans le programme : la Bolivie, la République du Congo, le Ghana, le Honduras, Madagascar, le Nigéria, le Suriname et l'Ouganda. Le Programme « *Opportunités Globales pour le Développement à long terme du secteur minier artisanal et à petite échelle* » GOLD+, est un projet pluriannuel qui va démarrer en 2022.

La phase préparatoire du Projet GOLD+ Congo (PPG Congo) avait commencé en 2021 et s'était fixé pour objectif d'élaborer le document de projet détaillé, avec des annexes stratégiques, lequel constituera le socle de l'intervention du projet au Congo. Le document du projet détaillé (Pro.doc) a été rendu disponible et un atelier de restitution a eu lieu en 2021.

1.4. La réglementation sur le mercure

En matière de réglementation, un projet de décret réglementant la gestion du mercure et composés de mercure en République du Congo se trouve actuellement au département de l'Environnement.

En conclusion, la Convention de Minamata sur le mercure est un instrument international fondamental pour réduire ou éliminer les effets nocifs de la pollution au mercure et est mise en œuvre, petit à petit, dans notre pays.

II. Notions de base sur le mercure, effets néfastes du mercure et de l'amalgame dentaire sur la santé et l'environnement, par Dr WATHA-NDOUDY Noel, Chercheur à l'IRF du Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.

Cet exposé a été développé suivant les rubriques ci-après :

2.1. Les notions de base sur le mercure

Le mercure est le seul métal qui se présente sous forme liquide à température ambiante. Le mercure élémentaire est lourd, inodore et de couleur argentée. C'est un élément extrêmement rare de la croûte terrestre.

Les propriétés du mercure sont : La volatilisation, La persistance dans l'environnement, La bioaccumulation, Il est neurotoxique, toxique, écotoxique et perturbateur endocrinien.

2.2. Les formes chimiques du mercure sont :

Élémentaire

- Métallique

Inorganique

- Chlorure mercurique
- Sulfure de mercure (cinabre)

Organique

- Méthyle, éthyle, diméthyle

2.3. Le cycle du mercure dans l'environnement :

Le mercure est : émis par l'activité humaine et les sources naturelles, évolue dans l'atmosphère pendant un à plusieurs années, déposé encore sur terre, dans les cours d'eau ou en mer, converti en formes insolubles, se sédimente, converti par les bactéries en méthylmercure et entre dans la chaîne alimentaire (bioaccumulation), rejeté de nouveau dans l'atmosphère par le phénomène de la volatilisation. Sa pollution est rémanente suite à l'accumulation dans le milieu et les organismes.

2.4. Les risques du mercure pour l'environnement

- Pour les eaux, risque de dépasser la norme de concentration (zone de forte densité dans les cabinets dentaires) ;
- Pour les sols et l'atmosphère, les informations sont assez limitées, mais le risque est évident.

2.5. Les sources de mercure

Les principales sources de mercure dans le monde (à titre indicatif) sont :

- L'exploitation aurifère et la production de métal ;
- L'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or (1^{re} source mondiale)
- La combustion du charbon ;
- La production du ciment ;
- L'incinération des déchets ;
- Utilisation des produits contenant du mercure ;
- Incinération des déchets médicaux, etc.

2.6. Effets du mercure sur la santé

Ces effets dépendent : de la forme du mercure et du type d'exposition (aiguë ou chronique) ; de la voie d'exposition et de la dose mercurielle ; de l'absorption par le biais des aliments, de l'eau ou de l'air. Mais c'est la forme Méthylmercure qui est la plus toxique.

Le Méthylmercure est absorbé par le corps six fois plus facilement que le mercure inorganique, se concentre facilement dans les organismes et tout au long du réseau trophique, traverse la barrière placentaire et s'accumule dans le système nerveux central.

Des effets généraux sur la santé, aux symptômes des maladies occasionnées par le mercure dans toutes ses formes, plusieurs sortes de maladies ont été présentées.

2.7. Principales difficultés de mise en évidence

L'intoxication peut être très importante avant l'apparition des symptômes. Actuellement la détection du métal ne peut se faire que dans le sang, les cheveux et les urines. Les moyens techniques nécessaires ne sont pas encore présents dans notre pays.

III. Film "Japon - Retour sur la catastrophe écologique de Minamata"

Après avoir suivi le film, les participants ont dégagé deux enseignements :

- Le premier enseignement porte sur la valorisation d'un site contaminé par un produit toxique ;
- Le deuxième enseignement porte sur le fait que l'on peut être malade et se porter apparemment bien pourtant comme le pêcheur montré dans le film.

IV. Etat de lieu de la dentisterie au Congo et les alternatives actuelles, par le Dr MAMPOUYA Daniel, propriétaire d'un Cabinet dentaire.

4.1. Utilisation des amalgames dentaires au Congo

Dans le secteur de l'art dentaire au Congo, l'utilisation des amalgames pour la restauration des lésions carieuses et leur obturation reste le concept central de la thérapie. Les anciennes technologies des matériaux d'obturation sont encore utilisées et enseignées, alors qu'on discute déjà d'alternatives contre l'utilisation des amalgames et des matériaux nobles contenant ou associés au mercure.

4.2. Composition des alliages et leurs effets secondaires

Le mercure rentre en effet dans la composition de nombreux alliages. Le dentiste réalise l'amalgame avec une poudre d'alliages et de gouttes de mercure. Connaissant la toxicité de ce

métal liquide, il se pose le problème des effets secondaires aux praticiens, aux patients et à l'environnement. Les conséquences des restaurations par l'amalgame sont très évidentes.

Les amalgames doivent être peu à peu délaissés pour les composites qui ne présentent aucun danger.

4.3. Effets des amalgames sur le plan environnemental

Sur le plan environnemental, la règle générale est que l'excédent d'amalgame non utilisé en bouche doit être immédiatement enlevé et recueilli dans un récipient d'eau étanche, ce qui polluerait moins l'environnement.

4.4. Pouvoir corrosif et vapeurs de mercure

Pour le praticien, la découverte des nouveaux matériaux a permis de diminuer le pouvoir corrosif de certains amalgames de l'alliage classique d'argent – étain – mercure.

Les mélanges réalisés manuellement au pilon et au mortier, les dosages et les mélangeurs mécaniques (adjonction de gouttes de mercure) et l'utilisation de capsules non dosées sont fortement déconseillés, car ils favorisent la concentration des vapeurs de mercure dans le cabinet dentaire.

L'excédent d'amalgame ou les éventuelles chutes de mercure pourraient se loger sur le relief du parquet du cabinet dentaire. Il faut savoir que, plus les gouttelettes du mercure sont petites, plus le dégagement de vapeur est important. L'enlèvement des anciens amalgames doit se faire à l'aide des turbines, sous irrigation et à petite vitesse, sans exercer de pression, ni d'échauffement.

4.5. Mesures préventives

Les mesures préventives contre les vapeurs de mercure ne sont pas appliquées dans notre pays, il est dans ce cas nécessaire *de surveiller particulièrement l'état de santé des praticiens et de leurs assistants* car la situation de vapeurs de mercure est sérieusement préoccupante.

V. L'amalgame dentaire dans l'évaluation initiale du mercure en République du Congo. Amendement africain sur l'amalgame dentaire à la COP4 de la Convention de Minamata. Résultats de la COP4 de la Convention de Minamata sur le mercure par Dr LOUBAKI Eugène, Président de l'association Action sur l'Environnement et le Développement (AED).

5.1. Les amalgames perdent-ils leur mercure avec le temps?

- Les recherches scientifiques ont maintenant démontré que les amalgames dentaires libèrent continuellement de la vapeur de mercure.
- Les quantités de vapeurs de Hg émises sont extrêmement variables, et le cerveau est le lieu de destination privilégié (Pleva, 2002).

5.2. Rejets du mercure dans l'environnement

L'identification des catégories et sous catégories et les calculs d'émissions ou des réjets de mercure ont été possibles grâce au document : *Outil d'Identification et de Quantification des*

Au Congo en 2018, l'évaluation initiale du mercure a montré que la quantité globale des émissions et de rejets de mercure est de 21 368 kg Hg/an (Rapport de l'inventaire du mercure en République du Congo, novembre 2018, Projet MIA – Congo). Les amalgames dentaires génèrent 373 kg de mercure, soit environ 2% de la quantité totale.

La quantité globale des émissions et de rejets de mercure de 21 368 kg/an a été rapportée à la population et à la superficie du pays, les taux suivants ont été trouvés.

En se référant à la population de l'année 2014 (4 666 379 habitants) et à la superficie du pays (342 000 Km²), les taux suivants sont obtenus :

- 4,58 g Hg/hab./an, soit **0,2 µg Hg/kg** de poids corporel/jour (en considérant que le poids moyen des habitants est de 70 kg) ;
- 62,48 g Hg/km²/an.

Tenant compte du niveau de référence qui est de **0,1 µg Hg/kg** de poids corporel/jour prescrite par l'EPA des Etats-Unis (US EPA), le rapport sur la population indique que l'exposition des populations aux sources d'émission et de rejet de mercure est un danger potentiel au Congo.

5.3. Amendement africain à la Convention de Minamata sur le mercure

L'article 4 de la Convention de Minamata sur le mercure concerne les produits contenant du mercure ajouté et sont cités à l'Annexe A du texte de la Convention où ils sont classés en deux parties. Ces deux parties de l'Annexe A se distinguent par :

Première partie de l'Annexe A	Deuxième partie de l'Annexe A
Avec date butoir d'abandon définitif	Sans date butoir d'abandon, mais des dispositions
Concerne : Les Piles, Ampoules, commutateurs relais, cosmétiques, Pesticides, biocides et antiseptiques Locaux, instruments de mesure	Concerne : Les amalgames dentaires

Cet état de fait a provoqué une forte indignation au niveau de la société civile au niveau international qui l'a exprimé à travers plusieurs déclarations. Elle n'accepte plus ce qui s'est passé avec la peinture au plomb, en laissant commercialiser cette peinture dans les pays en développement, alors qu'elle est interdite de vente et d'utilisation dans les pays industrialisés.

Dès 2018, des réglementations d'élimination de l'amalgame dentaire ont été prises dans l'Union Européenne et ailleurs pour d'abord protéger les enfants de moins de 15 ans, pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes et après, pour toute la population.

5.3.1. Proposition d'amendement à la COP4 de la Convention de Minamata

L'amendement africain à la Convention de Minamata sur le mercure propose de ramener les amalgames dentaires de la Deuxième partie à la Première partie de l'Annexe A de la Convention de Minamata, avec des dates butoir d'abandon définitif.

Produit avec mercure ajouté Première partie de l'Annexe A	Date butoir proposée d'élimination, de fabrication, d'importation ou d'exportation
--	--

Amalgame dentaire destiné aux dents abimées d'enfants de moins de 15 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes.	2021
Amalgame dentaire, en l'absence d'alternative sans mercure disponible.	2024

5.3.2. Décision MC-4/3 de la COP4: Examen et amendements des annexes A et B de la Convention de Minamata

- Les parties doivent :
- (i) Exclure ou ne pas autoriser, en prenant les mesures appropriées, l'utilisation du mercure en vrac par les praticiens de l'art dentaire;
- *(C-à-d, utilisation du mercure sous forme pré-dosée ou encapsulée par les soignants et praticiens de la dent);*

(ii) Exclure ou interdire, en prenant les mesures appropriées, ou déconseiller l'utilisation d'amalgames dentaires pour le traitement dentaire des dents de lait, des patients de moins de 15 ans et des femmes enceintes et allaitantes, sauf lorsque cela est jugé nécessaire par le praticien de l'art dentaire en fonction des besoins du patient.

5.3.3. Que dit la convention de minamata face à l'Amendement Africain après la COP4?

- Selon l'article 26: Amendement à la Convention
- Paragraphe 5. « La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties ayant accepté d'être liées par ses dispositions le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par au moins les trois quarts des Parties qui étaient Parties au moment où l'amendement a été adopté...

Mettre fin à l'utilisation de l'amalgame chez les enfants, les jeunes et les femmes enceintes et les femmes allaitantes d'ici le 25 juin 2022.

- Le Secrétariat a discuté de l'amendement relatif à l'amalgame, mais il n'a pas fait remarquer aux parties à la convention de Minamata que cet amendement devait entrer en vigueur dans **90 jours après son adoption par les Parties comme le dit l'article 26, para 5.**

5.4. Propositions de l'Alliance Mondiale pour la Dentisterie sans Mercure

1. Sensibiliser les gouvernements (parties et pays non-parties) aux droits, avantages et obligations découlant de l'adoption de cet amendement, afin d'améliorer leur connaissance et leur compréhension de l'amendement ;
2. Aider à formuler un modèle de législation (loi, décret, arrêté) pour la mise en œuvre de l'amendement, pour améliorer le respect des dispositions de la convention et le proposer au gouvernement à travers les personnes compétentes (Points Focaux) ;
3. Toutefois, chaque État est libre de concevoir les mesures de mise en œuvre et d'exécution de cet amendement qui sont les plus adaptées à son propre système juridique.

VI. S'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes au Congo par Mr Joseph MOUDZINGOULA, Secrétaire Général de l'AED.

L'exposé s'est articulé sur les points suivants :

6.1. Les pays actuellement dans le processus d'interdiction de l'amalgame dentaire;

De nombreux pays occidentaux ont déjà interdit l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, compte tenu des effets dommageables du mercure sur le jeune enfant.

Certains pays africains comme l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et le Togo, s'organisaient déjà avant 2020 pour mettre fin à l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants et ont proposé l'élimination de l'amalgame au sein de leurs populations en 2022.

6.2. Comment s'engager à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo ?

► Organiser des campagnes de sensibilisation sur les risques causés par le mercure en vue de parvenir à la fin de l'amalgame sur toute l'étendue du territoire national.

► Sensibiliser et éduquer la population en multipliant des stratégies de communication sur les dangers de l'utilisation des amalgames dentaires. Parmi ces stratégies on peut citer :

- ☐ la réalisation et la diffusion des spots télévisés sur le danger des amalgames dentaires ;
- ☐ la confection des tee-shirts et autres supports de communication ;
- ☐ la conception et la distribution des prospectus sur le danger de l'amalgame dentaire.

► Sensibiliser chaque acteur impliqué dans la filière de l'amalgame dentaire (cabinets dentaires, pharmacie, importateurs) sur les effets nocifs du mercure en général et de l'amalgame dentaire en particulier ;

► Faire la promotion des nouveaux matériaux composites non toxiques de restauration dentaire ;

► Eduquer pour faire respecter l'hygiène dentaire après chaque repas. Surtout éviter les aliments sucrés, glacés etc.

► Former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l'utilisation des matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion de l'utilisation des meilleures pratiques dans le domaine de la dentisterie.

6.3. La réglementation actuelle de notre pays contient-elle des dispositions qui permettent de bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo ?

► La Convention de Minamata sur le Mercure a été ratifiée le 17 mai 2019 et est arrivée au secrétariat de la Convention le 06 août 2019.

► Il faut des textes réglementaires pour mettre en application les dispositions de cette convention.

► La sensibilisation des parties prenantes est utile à cet effet.

► Cette question de réglementation ne peut être traitée que par les pouvoirs publics.

6.4.Quels sont les acteurs du pays qui peuvent contribuer à bannir à moyen terme l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes en République du Congo et quel est le rôle de chacun des acteurs ?

- ▶ Les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé, la population sont les acteurs du pays qui peuvent contribuer à ce bannissement.
- ▶ Tous les acteurs impliqués dans la filière de l'amalgame dentaire (importateurs, pharmaciens, dentistes, patients, manipulateurs des déchets de mercure) devraient s'engager résolument à bannir à moyen terme l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans le pays.
- ▶ Les différents ministères concernés pour l'initiation des textes réglementaires et législatifs si possible.
- ▶ Les organes de sensibilisations (associations) pour la diffusion des informations.
- ▶ Les praticiens (dentistes) pour la mise en pratique des dispositions de la réglementation.
- ▶ Les pouvoirs publics concernés pour interdire l'importation des produits contenant le mercure.
- ▶ Les pouvoirs publics concernés pour arrêter aux frontières les produits contenant du mercure.
- ▶ Les associations des consommateurs pour suivre auprès des commerçants les produits contenant le mercure.
- ▶ Les orpailleurs pour qu'ils n'utilisent plus le mercure dans l'extraction de l'or.
- ▶ Les dentistes pour qu'ils n'utilisent plus l'amalgame au niveau des cabinets dentaires.
- ▶ les organes de presse (écrite et audiovisuelle) pour faire la communication aux fins d'atteindre la plus grande masse de la population.
- ▶ Les chercheurs pour mettre au point des données fiables sur les impacts réels du mercure sur la santé et l'environnement en République du Congo.
- ▶ Les éducateurs pour la sensibilisation, l'éducation et la formation.
- ▶ Les ONG et associations sont appelées à faire le plaidoyer et la sensibilisation ;
- ▶ Les pharmaciens et les dentistes sont appelés à bannir les amalgames au profit des composites;
- ▶ Les médecins dentistes devraient s'orienter vers l'abandon total des pratiques avec les produits toxiques tels que le mercure.

Bannir à moyen terme l'utilisation de l'amalgame dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes est une préoccupation fondamentale qui interpelle tous les acteurs.

VII. Suggestions

Après la phase des questions / Réponses, les suggestions suivantes ont été formulées :

- La question sur la toxicité du mercure étant importante il a été suggéré que plusieurs ONG se mettent ensemble pour mener le plaidoyer auprès des pouvoirs publics ;
- Il faut mener des études pour mesurer l'impact du mercure sur la santé de la population ;
- Faire des analyses au niveau du sang, des cheveux et de l'urine pour détecter la présence du mercure dans le corps humain. Malheureusement les chercheurs ne disposent pas des moyens matériels et financiers pour mener ce genre d'analyses dans notre pays actuellement ;

- Les scientifiques ont normalement le devoir de déterminer les sites contaminés comme cela se fait dans d'autres pays qui analysent l'état de leurs plages pour informer les habitants sur les possibilités de se baigner. Ainsi, pour savoir que tel ou tel site est contaminé au mercure il faut des analyses scientifiques ;
- Le mercure est certes volatil, mais il a la possibilité de changer en méthylmercure et autres formes. Il est ainsi impossible de le séquestrer ;
- Il faut des arguments techniques et scientifiques pour convaincre le monde scientifique de la dangerosité du mercure. Les acteurs cibles dans ce cas sont l'ordre des médecins, les pharmaciens, les dentistes ;
- Il apparaît important de réaliser des études. En cela, l'Etat doit être le Leader en associant le monde scientifique. L'Etat devait subventionner l'acquisition des alternatifs à l'amalgame dentaire pour baisser les coûts des composites ;
- L'une des suggestions la plus importante est de **faire la prévention de la carie dentaire** dans le pays pour réussir la non utilisation du mercure dans la réparation des dents.

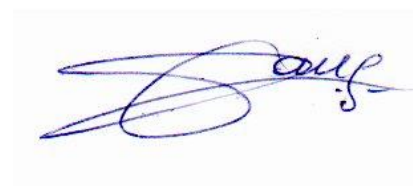
CONCLUSION

En règle générale, la mise en place d'une réglementation adéquate et une sensibilisation accrue dans tout le territoire national, pourront stopper l'utilisation de l'amalgame dentaire dans le pays. A ce propos, l'AED a déjà déposé en 2019, un projet de réglementation sur le mercure au Ministère en charge de l'Environnement.

A la fin des travaux, le Président de l'AED a félicité tous les participants pour l'intérêt manifesté par eux sur les problèmes de l'amalgame dentaire et a souhaité bon retour à chacun des participants.

Fait à Brazzaville, le 26 mai 2022

Le Secrétaire Général de l'AED



MOUDZINGOULA Joseph

ANNEXES

ANNEXE N°1 : ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT DE L'AED.

Chers Mesdames, et Messieurs,

Bonjour !

Nous, Association Action sur l'Environnement et le Développement en sigle "AED" et les consultants qui nous accompagnent, venons communiquer sur un sujet assez préoccupant, il s'agit du mercure et en particulier, de l'amalgame dentaire faussement appelé "plombage gris, mélange de mercure avec d'autres métaux tels que l'argent, l'étain et le cuivre.

Ce matériau est largement utilisé dans notre pays, aux fins de réparation des dents abimées parce qu'il est durable, s'insère facilement dans la dent creusée et ne coûte pas cher. Mais la sécurité biologique de l'amalgame est aujourd'hui contestée, car le mercure qui est un métal lourd, est une substance indésirable et potentiellement très nuisible pour le corps humain et l'environnement. L'OMS le cite d'ailleurs comme un des dix polluants les plus préoccupants pour la santé humaine.

La situation la plus préoccupante est celle de l'exposition au mercure du jeune enfant dont le cerveau est en développement, notamment de l'enfant de moins de 15 ans, du fœtus dans le ventre de sa mère car le mercure peut traverser le placenta, et du bébé qui consomme le lait mercuriel du sein de sa maman si celle-ci a été exposée au mercure de l'amalgame dentaire ou d'une autre source contenant du mercure.

En plus du mercure, l'exposition à d'autres produits chimiques est inquiétante dans notre pays. Regardons le nombre d'enfants qui souffre d'autisme, le nombre de femmes qui souffre de fausse-couche. Regardons l'environnement dans lequel nous vivons, un environnement dans lequel nous sommes exposés à plusieurs produits chimiques dont le mercure bien sûr. Que faisons-nous de nos piles et batteries usagées, des déchets des ampoules à mercure de faible consommation, de l'utilisation de la peinture au plomb, des pesticides non rationnellement utilisés et éliminés, des déchets de nos équipements électriques et électroniques contenant divers produits toxiques. Il faut que nous prenions des dispositions pour mieux gérer ces produits chimiques et leurs déchets, et réduire nos peines.

Pour revenir à l'amalgame, Des solutions de remplacement existent, comme nous allons le voir tout au long de cet atelier.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, de m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier d'avoir abandonné vos occupations, afin de venir prendre part à cette conférence de presse. Cela témoigne de l'importance que vous accordez à cette communication sur l'amalgame dentaire, objet de la conférence de presse.

Je vous remercie.

ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS

N°	Nom et Prénom	Structure	Téléphone et courriel	Emargement
01	Roland KOULOUNGOU	Horizon Africain	06 838 30 04	
02	BOSSO Marleine	DGE	06 728 16 28	
03	NGOUMBA Blaise	DGE / BOC	06 665 30 63	
04	NTINO Angélique	Mouvement des mères	06 647 64 92	
05	MOUDZINGOULA Joseph	AED	06 666 36 39	
06	BAZOMA DONGUI Geneviève	PFCM /DGE	06 803 58 94	
07	MALONGA – MALONGA Eric Gélase Billy	Pdt national ACC	06 626 29 41	
08	MOUSSALA Dieudonné	Pdt A.C.D.D.C	05 556 18 82	
09	Philippe BAZ	Semaine Africaine	06 666 21 90	
10	Guimel NKOUNKOU	ALGEC	06 612 12 50	
11	WATHA - NDOUDYN	IRF	06 979 71 41	
12	SAFOULA Virgile	EDIC	06 428 31 38	
13	GANONGO Joseph	AED	06 995 59 19	
14	BOKILAMA Lydie M.	VOX-TV	05 663 22 74	
15	KOUBEMBA Vincent de Paul	DRTV	06 665 76 10	
16	MASSAMBA Michael	DRTV	06 666 46 34	
17	KOULOUNGOU Ruth	VOX - TV	06 969 60 25	
18	KOMBO Fiacre	Dépêche de BZV	06 647 61 46	
19	Dr Daniel MAMPOUYA	Cabinet dentaire	06 570 57 13	
20	KOBAT Leger	AED	06 679 21 68	
21	KOUKA Pré-Samuel	CCSC / ONG	06 650 71 70	
22	LOUKENGO Augustin	Logisticien	06 650 03 93	
23	BITSOUMANI Amélie	DGE (C.S.E.E.)	06 847 78 50	
24	NIANGO Maurice	AED	06 679 77 25	
25	LOUBAKI Eugène	AED	06 952 28 51	
26	Dr MOLOUMBA Felix	MSP	06 946 50 96	

